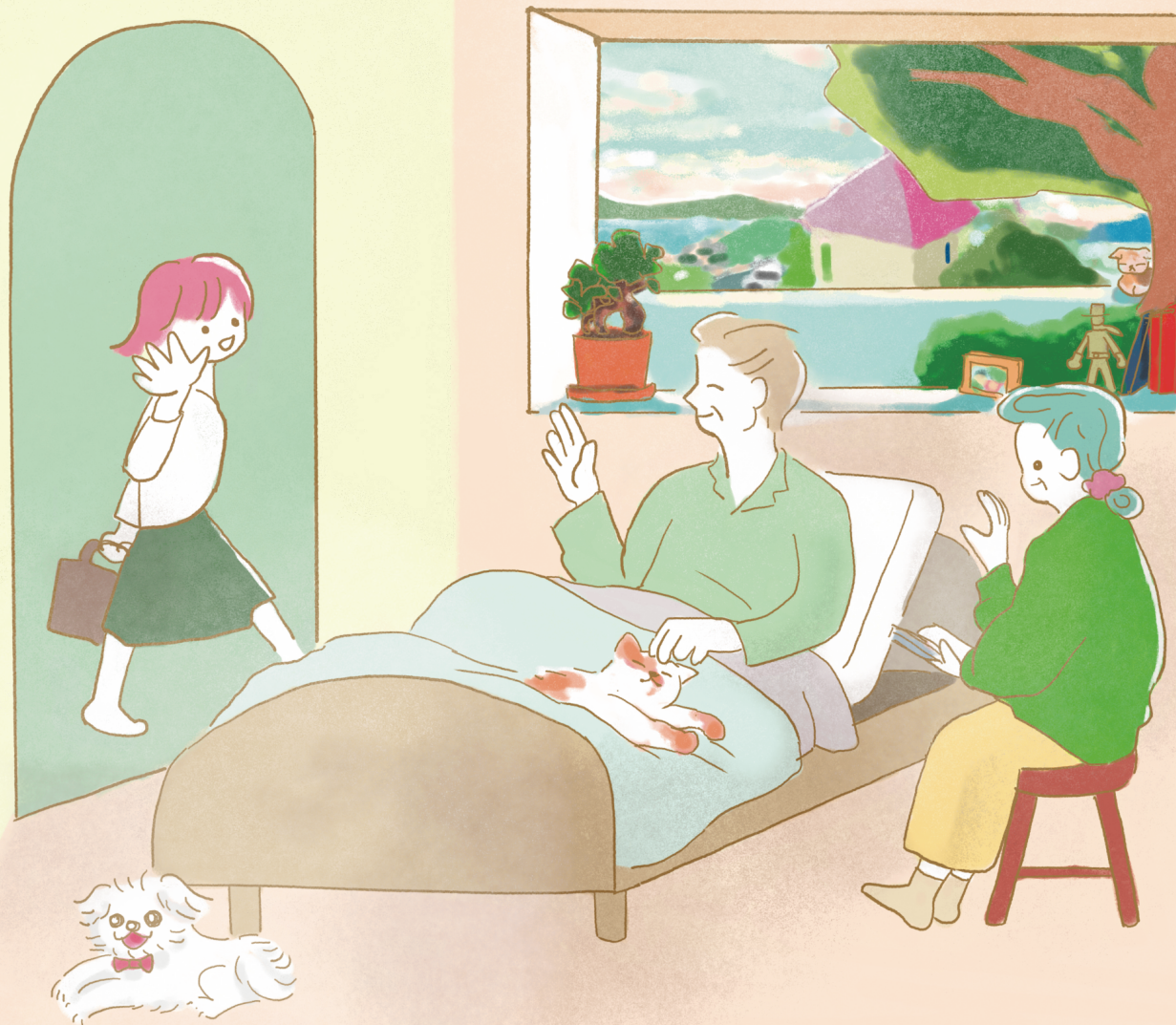


在宅医療

住み慣れた場所でいつまでも

在宅医療の基礎知識 | 専門職がチームで「在宅医療」を支えます | 在宅医療のはじめかた



はじめに

東彼杵郡でも急速に高齢化が進んでいます。なかでも医療や介護を受ける割合が高くなる75歳以上の方が急激に増加し、それに伴い死亡者数も増加すると予測されています。

いまは病院で最期を迎える方が多いのですが、入院できるベッドの数には限りがあり、今後最後まで病院で療養できなくなる人が増えてくると考えられます。そのため早いうちから準備しておくことが大切です。

また、最近では、最期をどこでどのように暮らしたいか、ご自身で考えたいという方が増えてきました。

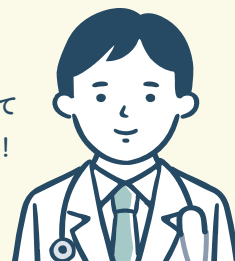
この冊子では、「病気があってもできるだけ長く家で暮らしたい」と考える方へ「在宅医療」についてご紹介します。「在宅医療ってどんなこと?」「どうやってはじめればいいのか?」といった疑問にできるだけわかりやすくお答えします。

ぜひ一度、自分の事として「在宅医療」をとらえ、ご自身の将来を考える助けにさせていただきたいと思います。



1.

まずは
在宅医療について
知ってくださいね！



在宅医療の 基礎知識

病気であっても

住み慣れた場所で安心して
暮らすことができます

在宅医療とは、自宅などの住み慣れた場所に医師や看護師などが訪問して、診察や治療を行う医療のことです。通院するのが難しくなった時や末期がんなど、重い病気にかかっても家で生活を続けたい時などに受けることができます。

また、自分の家だけではなく、有料老人ホームやグループホームなどでも在宅医療を受けることができます。在宅医療の一番良いところは、住み慣れた場所で以前と同じように過ごせることです。

子どもから高齢者まで

全ての年代で受けられます

病気を抱えた一人暮らしの高齢者や認知症と診断された方などは、家で生活が続けることが難しいと思われがちですが、在宅医療と介護保険サービスを併せて受けたり、家族や周囲の人に協力してもらったりすることで、家で暮らし続けられる例もたくさんあります。



さまざまな病気に対応できます

脳や心臓などの病気で手術を受けた後や、がんの療養、慢性的な病気では、多くの場合で在宅医療を受けることができます。例えば、がんの場合には薬で痛みを和らげることもできます。

問診や採血などの検査、注射、点滴などの治療を行うほか、人工呼吸器など家でも安心して使える機器を設置することもできます。

入院・通院する時と同じように医療保険が使えます

在宅医療にかかる自己負担額は、入院・通院する時と同じように、かかった医療費の1～3割となります。また、食事や入浴の介助など日常生活のサポートが必要な時には、介護保険を申請して要介護認定を受けることで、一定の自己負担額で介護保険サービスを利用することができます。



ポイント

家計への負担を 軽くする制度が あります

医療費や介護費が高くなり、家計への負担額が大きくなりすぎないように、月の支払額が一定金額*を超えた場合にその額が後で払い戻される「高額療養費制度」「高額介護・高額介護予防サービス費」「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。

* 年齢や所得などによって変わります。



まずは「かかりつけ医」に 相談しましょう

在宅医療を受けてみたいと思ったら、まずは「かかりつけ医」に相談しましょう。日頃からかかりつけ医を決めておくと、病状や健康状態を把握してくれます。かかりつけ医は、在宅医療に限らず、健康管理のアドバイスや専門医療機関への紹介など、さまざまな面で頼りになります。



緊急時にどうするか 医師や看護師と事前に 相談しておきましょう

在宅医療を行う医療機関や訪問看護ステーションでは、急に体調が悪くなった時に備えて、医師や看護師に24時間連絡が取れる体制を整えているところも多くなっていますので事前に相談しておきましょう。

医師や看護師が患者さんやご家族など希望や不安について相談に乗り、適切なアドバイスをしてくれます。

ポイント

各町にある

「地域包括支援センター」は
介護・保健のよろず相談所



在宅医療だけでなく介護や生活のことでも不安があるときは、各町の地域包括支援センターにご相談ください。センターでは高齢者の健康や福祉、介護などに関する相談やアドバイス、支援をおこなっています。「今すぐ必要という訳ではないけれど…」「何から相談したら良いかわからない…」そんな時でもお気軽にご相談ください。（センターはお住まいの地域で担当が決まっています。担当のセンターがわからない時は、資料の「相談窓口」にお問合せください。）



2. 専門職がチームで「在宅医療」を

在宅医療のチームリーダー

医師

自宅を訪問して、治療や診察、経過観察を行います。病状や経過から治療方針を立てて、適切な療養生活ができるようにそのほかのメンバーに指示を出す在宅医療のリーダーとしての役割もあります。



患者さん・家族などの頼りになるパートナー

訪問看護師

自宅を訪問して、療養生活の世話や病状の観察、医師の指示による医療処置などを行います。また、家族や周囲の人ができる介護の方法など、さまざまな相談に乗ります。患者さんや家族に寄り添う強い味方です。



「噛む」「食べる」の専門家

歯科医師・歯科衛生士

自宅を訪問してむし歯や歯周病の治療、入れ歯の調整などを行います。お口のケアやリハビリテーションを行うことで、誤嚥（ごえん）性肺炎の予防もできます。お口の環境や噛み合わせが良くなると食べる楽しみが回復します。



マネジメントの専門家

介護支援専門員（ケアマネジャー）

主に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに勤務し、介護が必要な方の相談に乗り、心身の状態に合わせて、介護サービスの計画（ケアプラン）を立て介護サービスを受けられるよう調整します。



支えます

※ここにあげた以外にも介護の専門家の力を借りることで
日常生活のサポートを受けることができます。

薬のお困り事を解決する専門家

薬剤師

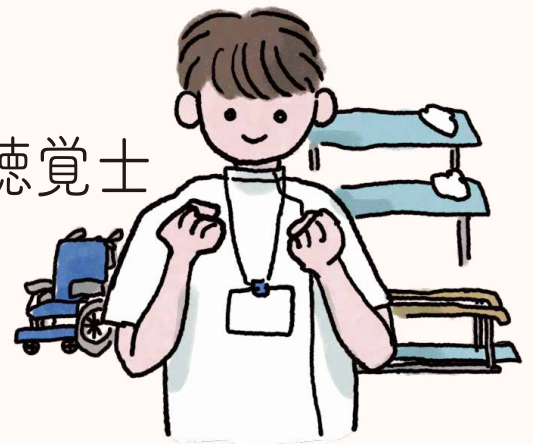
薬を自宅に届け、服薬状況を確認し、飲み忘れを減らす工夫、飲み合わせや副作用のチェック、その人の生活に応じた薬への変更の提案などを行います。



リハビリと生活の環境づくりの専門家

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

自宅を訪問して、症状や状態に応じて体の動かし方や補助器具の使い方を指導したり、食べることやコミュニケーションの方法についても支援を行います。



食事と栄養の専門家

管理栄養士

自宅を訪問して、低栄養の改善、病状や栄養状態にあわせた食事に関する支援を行います。患者さんの食事の好みや、飲み込んだり嚥んだりする力にあわせて、調理方法やレシピを提案したりします。



在宅医療に詳しい病院の相談員

医療ソーシャルワーカー

病院から退院して自宅に戻るときなどに、患者さんや家族などと相談しながら、他のメンバーとのサービス調整をしたり、自宅でのよりよい生活づくりを提案します。





ポイント

相談する時に 伝えること

- 通院が難しくなって、在宅医療を受けることを考えてみたい
- 病気や体の調子について日頃不安に思っていること
- 家族や住まいなどの状況
- 現在、利用している介護保険サービス

3.

在宅医療のはじめ方

通院が難しくなった時には、どのように相談したらいいの？

かかりつけ医や地域包括支援センター、
担当ケアマネジャーに相談しましょう

通院が難しくなったこと、在宅医療を受けることができないか考えていることをかかりつけ医に相談しましょう。併せて、家で生活する上で不安に感じていることも伝えることが大切です。

かかりつけ医がそのまま継続して在宅医療を行う場合もあれば、別の医師を紹介する場合があります。

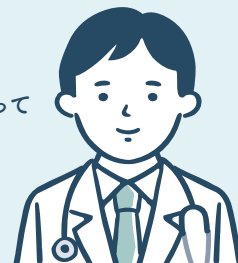
かかりつけ医を決めていない場合で医療機関の情報を知りたいときは、各町の地域包括支援センターにご相談ください。

また、すでに介護保険サービスを利用している人は担当のケアマネジャーに相談してみるのもいいでしょう。



退院する時には
どのように
相談したらいいの？

在宅医療を知って
はじめてみましょう！



まずは病院のスタッフに 相談しましょう

病院によっては「地域連携室」や「医療相談室」といった、患者さんが退院する時の調整を行っているところがあり、医療ソーシャルワーカーや専門の看護師がいます。「退院後は家に帰りたい」「家で暮らしたいが不安がある」といった患者さん本人やご家族などの要望や懸念していることを伝えてください。病院内のスタッフや、必要に応じて家で在宅医療を担当する医師や看護師、介護の専門職と、退院後の準備を進めるよう提案してくれます。



在宅医療と病院は 併行してかかることが できます

多くの人が症状や状態に応じて在宅医療と病院とを併行して受診しています。例えば、日頃の病状管理は家で行い、がんなど専門的な治療が必要な場合であれば、入院して抗がん剤治療を受けることができます。また、急に体調が悪くなった時などには、一時的に入院することも可能です。



家族など周囲の人に
負担がかかるのでは？

医療・介護のサービスで 負担を軽減できます

病院に入院した場合だと、看護師や病院のスタッフが身の回りのことをしてくれますが、在宅医療では、家族など周囲の人からの協力が必要になることもあります。

そのため、多くの方が在宅医療と介護保険のサービスを合わせて使い、食事や入浴の介助など日常生活の支援を受けながら家での生活を送っています。

また、家族などが遠くに住んでいたり、仕事をしていて協力が難しい場合もあります。その時にも緊急時に家族などにお知らせがいく見守りサービスなどをうまく組み合わせることで、周囲の負担を軽くすることができます。

このように在宅医療を受けるときには、ご自身だけでなく家族など周囲の人との協力と心づもりも必要になりますので、事前に話合っておくことが大切です。



ポイント

住宅改修や福祉用具、 医療器具等の利用に 保険が使えます

介護用ベッドや住宅の改修などが必要な時にはお金がかかります。しかし、車イスや介護用ベッドなどの用品のレンタルや、自宅に手すりを付けたりする改修工事に介護保険を使うこともできるので、自己負担の金額をおさえることができます。また、酸素吸入などの機器が必要な場合、その多くは医療保険を使って利用することができます。



介護保険を使うには
どうしたらいいの？

要介護認定を受ける 必要があります

65歳の誕生日を過ぎると、市町村から「介護保険被保険者証」が届きます。しかし、保険証があるからといって、介護保険サービスをすぐには使うことができません。介護保険サービスを利用するには、申請をおこなって「要介護（要支援）認定」を受ける必要があります。申請から利用まで、おおよそ1か月ほど時間がかかりますので、必要だと思われるら早めに相談することをお勧めします。

要介護（要支援）認定を受けると、次はケアマネジャーに依頼して、介護保険サービスの計画（ケアプラン）を作成し、介護保険サービスを利用できます。

介護保険サービスの利用については、各町の介護保険係または地域包括支援センターにご相談ください。

｜ポイント｜ 40～64歳の方も
特定疾病のときに限り
介護保険を利用できる
場合があります



40～64歳の方は介護保険の「第2号被保険者」に該当します。第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護（要支援）認定を受けたときに介護保険サービスを使うことができます。対象となる特定疾病は、脳血管疾患、がん末期、初老期における認知症など、16種類が定められています。

ご自身の連絡先を記録しておきましょう

● かかりつけ医



● 訪問看護ステーション



● ケアマネジャー



各町の
相談窓口



東彼杵町

長寿ほけん課ほけん年金係 ☎ 0957-46-1202

地域包括支援センター ☎ 0957-46-1173



波佐見町

長寿支援課長寿介護班 ☎ 0956-80-6655

地域包括支援センター ☎ 0956-85-2976



川棚町

長寿支援課長寿介護係 ☎ 0956-59-5883

地域包括支援センター ☎ 0956-59-5886



東彼杵郡在宅医療

介護連携支援センター ☎ 0956-37-6270

たんぽぽ